

**JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE SALUD**

**SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS**

INSPECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD MÉDICA DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES

CÓRDOBA



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN
MATERIA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL
2023**

Esther Álvarez Theurer

Índice

	Página nº
1. CONCEPTO DE INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.)	4
2. PARTE MÉDICO DE BAJA	5
3. PARTES MÉDICOS DE CONFIRMACIÓN DE LA BAJA MÉDICA	6
4. PARTE MÉDICO DE ALTA	7
5. PRESENTACIÓN DE LOS PARTES DE I. T.	8
6. EXTINCIÓN DEL DERECHO AL SUBSIDIO POR I. T.	8
7. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR	9
8. REQUERIMIENTO A LOS TRABAJADORES PARA RECONOCIMIENTO MÉDICO	9
9. EXPEDICIÓN DE PARTES DE BAJA POR ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T.)	11
10. REVISIÓN DE ALTAS MÉDICAS DE A.T. EXPEDIDAS POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12
11. EXPEDICIÓN DE PARTES DE BAJA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL (E.P.)	13
12. CAMBIOS DE CONTINGENCIA	13
13. NUEVA BAJA TRAS ALTA POR INSPECCIÓN MÉDICA SPS	14
14. NUEVA BAJA TRAS ALTAS POR INSPECCIÓN DEL INSS	14
15. PRESCRIPCIÓN DE NUEVAS BAJAS TRAS ALTA POR FACULTATIVO DEL INSS AGOTADO EL PLAZO DE 12 MESES DESDE EL INICIO DE LA I.T.	15
16. PROPUESTAS DE ALTA DE LOS FACULTATIVOS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15
17. ORDEN O INDICACIÓN DE ALTA POR LA UMVI	16
18. INCOMPARECENCIA DEL TRABAJADOR A RECOGER LOS PARTES DE CONFIRMACIÓN	16
19. TIPOS DE ALTA POR EL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA	16
20. RECLAMACIONES CONTRA EL ALTA	17

21. INFORMES EN PARTES DE CONFIRMACIÓN	18
22. INICIO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE	18
23. DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN I.T.	18
24. ACÚMULOS DE PERIODOS DE I.T.	19
25. SOLICITUD DE CONTROL DEL ASEGURADO	19
26. RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LACTANCIA NATURAL	19
27. PROCESOS DE I.T EN PACIENTES ASEGURADOS EN OTROS PAISES DE LA U.E.	21
28. PROCESOS DE I.T EN PACIENTES ASEGURADOS EN OTROS PAÍSES MIEMBROS DE LA U.E. QUE SE TRASLADAN A ESPAÑA	22
29. TRASLADO DE DOMICILIO A OTRO PAIS EN SITUACIÓN DE I.T.	23
30. I.T. Y NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	24
31. I.T. Y PLURIEMPLEO/PLURIACTIVIDAD	25
32. I.T Y DESEMPLEO	25
33. I.T. Y VACACIONES O PERMISOS	26
34. SOLICITUD DE BAJA POR MOTIVOS SOCIOLABORALES	26
35. SOLICITUD DE BAJA DE PERSONAS SIN DERECHO A I.T.	26
36. I.T. E INGRESO EN PRISIÓN	27
37. I.T. Y LISTAS DE ESPERA	27
38. NEGATIVA DE UN TRABAJADOR EN IT A SEGUIR EL TRATAMIENTO PRESCRITO	27
39. TRABAJADOR QUE HA RECIBIDO ASISTENCIA SANITARIA AJENA AL S.A.S.	27
40. SOLICITUD DE I.T. CON CARÁCTER RETROACTIVO O ADELANTADO	28
41. BAJAS LABORALES EN TRABAJADORES QUE TIENEN RECONOCIDO UN GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE	28
42. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	28
NORMATIVA DE REFERENCIA	30

El Médico de Familia es responsable de la prescripción de la prestación de Incapacidad Temporal (IT), cuya gestión conlleva no pocas dificultades sociales, laborales, éticas y sanitarias. La magnitud del problema deriva de la cuantía del gasto que representa para las empresas y la Seguridad Social (SS). Este ha ido en aumento, pero también se ha incrementado la población afiliada a la SS. La IT no es una situación aislada del contexto biológico y social del paciente, pues la situación socioeconómico-laboral y la comorbilidad son claves para explicar la duración de la baja.

Calidad en la prestación de IT es la adecuación entre la incapacidad realmente padecida, los medios para evitarla y el tiempo necesario para ello. Determinar el tiempo promedio de duración de un proceso de IT, de acuerdo con la evolución de la enfermedad y sus posibilidades de tratamiento y rehabilitación contribuye a una adecuada gestión de la IT.

La inspección de servicios sanitarios debe ser el apoyo del Médico de Familia en la toma de decisiones, basadas en la mejor evidencia científica disponible y en la valoración de la alteración de la función y estructura corporal, relacionada con la limitación de la actividad.

1. CONCEPTO DE INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.)

Tendrán la consideración de situaciones determinantes de I. T., las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador por cuenta ajena o propia, reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social (Servicio Público de Salud o Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social) y esté impedido temporalmente para trabajar, con una duración máxima de DOCE MESES (prorrogables por otros SEIS MESES ÚNICAMENTE cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta laboral por curación o mejoría que permita su reincorporación laboral).

Agotado el plazo de duración de DOCE MESES previsto en el párrafo anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa por otros SEIS MESES MÁS, o bien, para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien, para emitir el alta médica (ley 40/2007).

De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquella se produzca en un plazo de seis meses posterior a la antes citada alta médica por la misma o similar patología.

Hasta el cumplimiento de los 365 días de los procesos de IT (Disposición adicional 52 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo), el INSS a través de sus inspectores médicos, podrá emitir un alta médica a todos los efectos. El INSS será el único competente

para emitir una nueva baja por misma o similar patología, si esta se produce en un plazo inferior a 180 días desde la mencionada alta.

Así mismo, son situaciones de I.T. los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos; con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

2. PARTE MÉDICO DE BAJA

El parte médico de baja de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se expedirá, inmediatamente después del reconocimiento médico de la persona trabajadora, por el facultativo del servicio público de salud que lo realice.

En general será prescrita por el Médico de Familia tras reconocimiento médico del trabajador. Durará, mientras a criterio del médico, se encuentre incapacitado para el trabajo; independientemente que precise continuar con tratamiento. La duración máxima es de 12 meses. A partir de éstos no existe la obligación de recoger partes de confirmación, pasando la competencia del control de esta prestación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), único que a través del órgano responsable de valoración, podrá prorrogar dicha situación hasta el mes 18, dar el alta laboral o iniciar un procedimiento de incapacidad permanente. Durante el período de baja, y hasta el mes 12, el trabajador está obligado a recoger partes de confirmación; para lo que deberá personarse en su Centro de Salud o Unidad de Gestión Clínica (UGC).

El médico CODIFICARÁ el parte de I.T. con el diagnóstico más adecuado al proceso clínico, mediante CIE 9 MC/CIE 10.

Cuando el trabajador haya tenido un proceso de I.T. previo y cause nueva baja en los seis meses siguientes por la MISMA O SIMILAR patología, el médico marcará la casilla de RECAÍDA.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, el parte médico de baja será extendido, en general, por el médico de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social excepto en aquellos trabajadores que tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en los que será emitido por su médico de familia.

El parte médico de baja es el único documento que justifica la ausencia al puesto de trabajo.

En los trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la cobertura de las contingencias profesionales es obligatoria.

El Servicio Público de Salud o la Mutua, según cuál sea la entidad facultada para emitir el parte de baja consignará los datos personales del trabajador y, además, los datos obligatorios del parte de baja relativos a la fecha de la baja, a la contingencia causante, al código de diagnóstico, al código nacional de ocupación del trabajador, a la duración estimada del proceso y, en su caso, la aclaración de que el proceso es recaída de uno anterior, así como, en este caso, la fecha de la baja del proceso que lo origina. Asimismo, hará constar la fecha en que se realizará el siguiente reconocimiento médico.

3. PARTES MÉDICOS DE CONFIRMACIÓN DE LA BAJA MÉDICA

Los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite. A estos efectos se establecen cuatro grupos de procesos:

a) En los procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la Mutua, emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico.

El facultativo, en función de cuando prevea que el trabajador va a recuperar su capacidad laboral, consignará en el parte la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la baja o cualquiera de los tres días naturales siguientes a esta. No obstante el trabajador podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado como fecha de alta, y el facultativo podrá emitir el parte de confirmación de la baja, si considerase que el trabajador no ha recuperado su capacidad laboral.

En este primer parte de confirmación, que dejará sin efecto el alta prevista en el parte de baja, se indicará el diagnóstico, la nueva duración estimada y el tipo de proceso, así como la fecha de la siguiente revisión médica.

b) En los procesos de duración estimada de entre 5 y 30 días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la Mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. En la fecha de revisión se extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí.

c) En los procesos de duración estimada de entre 31 y 60 días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la Mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de veintiocho días naturales entre sí.

d) En los procesos de duración estimada de 61 o más días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la Mutua, emitirá el parte de baja en el que fijará la fecha de la revisión médica prevista, la cual en ningún caso excederá en más de catorce días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte

de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de treinta y cinco días naturales entre sí.

Los plazos establecidos se entenderán, en todo caso, como plazos máximos, por lo que el facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrá expedir los partes de confirmación en un período inferior.

El facultativo del servicio público de salud, o el facultativo de la mutua o de la empresa colaboradora si se trata de contingencia profesional a su cargo, cuando emita el último parte de confirmación anterior al agotamiento de los trescientos sesenta y cinco días naturales de duración, comunicará a la persona trabajadora en el acto de reconocimiento médico que, una vez agotado el referido plazo, el control del proceso corresponderá en lo sucesivo al INSS en los términos establecidos en el artículo 170.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, informándole de que no emitirá más partes de confirmación. Todo ello sin perjuicio de que el servicio público de salud, la mutua o la empresa colaboradora le siga prestando la asistencia sanitaria que aconseje su estado.

A tal efecto, en dicho parte de confirmación, el facultativo, en lugar de la fecha de la siguiente revisión médica, cumplimentará el apartado correspondiente al pase a control por el INSS, señalando el día de cumplimiento de los trescientos sesenta y cinco días naturales en situación de incapacidad temporal.

El servicio público de salud comunicará telemáticamente al INSS la fecha del agotamiento de los trescientos sesenta y cinco días de manera inmediata a su cumplimiento y, en todo caso, no más tarde del primer día hábil siguiente.».

Esto no implica la obligación de reincorporación laboral del trabajador hasta que sea valorado por el INSS, a través del órgano colegiado EVI, y se emita la correspondiente resolución del Director Provincial.

4. PARTE MÉDICO DE ALTA

El parte médico de alta será expedido por el facultativo del SPS, Inspección Médica del SPS, INSS o Mutua, tras el reconocimiento de la persona trabajadora. El facultativo que expida el parte médico de alta entregará a la persona trabajadora una copia del mismo con la obligación de incorporarse al trabajo el día siguiente al de la expedición del parte.

Cuando el parte médico de alta sea expedido por el inspector médico del INSS o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, estas entidades trasladarán los datos contenidos en el parte de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de dicha expedición, al correspondiente servicio público de salud para su conocimiento y también a la mutua, en el caso de personas trabajadoras protegidas por la misma, con la finalidad de que esta dicte acuerdo declarando extinguido el derecho por causa del alta, sus motivos y efectos, y

notifique el acuerdo a la empresa.

La entidad gestora comunicará a la empresa, para su conocimiento, los datos meramente administrativos de los partes de alta médica de sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.

5. PRESENTACIÓN DE LOS PARTES DE I. T.

El facultativo que expida el parte médico de baja, confirmación o alta entregará a la persona trabajadora una copia de este.

El servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a su vez, comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua, referidos a sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso, de lo previsto en el párrafo siguiente.

Las empresas tienen la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja médica, los datos según la Orden ministerial ISM/2/2023, de 11 de enero.

La citada transmisión no será obligatoria cuando la persona trabajadora pertenezca a algún colectivo respecto del cual la empresa o empleador no tenga obligación de incorporarse al sistema RED; en este caso las comunicaciones se practicarán por medios electrónicos, a través del servicio correspondiente de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (SEDESS), de acuerdo con lo previsto en la regulación de las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, cuando el destinatario esté obligado a su utilización o hubiese optado por ella. En otro caso, la comunicación se realizará mediante correo ordinario.

6. EXTINCIÓN DEL DERECHO AL SUBSIDIO POR I. T.

El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo establecido en los párrafos anteriores; por ser dado de alta médica, con o sin declaración de incapacidad permanente; por haber sido reconocido el derecho al percibo de la pensión de jubilación; por incomparecencia injustificada a cualquiera de las citaciones a exámenes y reconocimientos médicos establecidos por los facultativos del INSS o de las Mutuas Colaboradoras con la

Seguridad Social; y por haber sido dado de alta por incomparecencia por los facultativos del sistema público sanitario, ya sea el médico de cabecera o la Inspección Médica; o por fallecimiento.

7. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

El trabajador tiene la obligación de facilitar a su médico de cabecera todos aquellos datos necesarios para la cumplimentación de los partes médicos de I.T., debiendo actualizar los datos contenidos en la tarjeta sanitaria del S.A.S. y, en especial, los relativos al domicilio. Asimismo, el trabajador comprobará que los datos consignados en los partes médicos de baja, confirmación y alta son los correctos.

El trabajador, salvo en caso de hospitalización u otro de fuerza mayor, tiene la obligación de ASISTIR PERSONALMENTE a consulta a recoger, previo reconocimiento médico, los partes médicos de baja, confirmación y alta laboral. La no comparecencia en la consulta médica para retirar dichos partes, y en los plazos previstos SERÁ MOTIVO DE ALTA LABORAL POR INCOMPARECENCIA, con fecha del día en la que debiera haber comparecido; con independencia de las obligaciones legales que pudiera incurrir por no presentar dichos partes en la empresa en los plazos previstos.

El trabajador que en situación de I.T. desee trasladarse a otra provincia, con motivo de residir temporal o definitivamente en otra localidad, deberá comunicarlo a su médico de familia, con el fin de realizar los trámites administrativos oportunos (Véase el pto. 22 de este Manual DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN I.T.).

Los trabajadores en situación de I.T., deberán seguir el tratamiento prescrito, evitando la realización de aquellas actividades cotidianas que de alguna manera perjudiquen el proceso de recuperación de su capacidad laboral, conociendo que la incapacidad temporal es incompatible con actividad laboral y/o estancia en su puesto de trabajo.

8. REQUERIMIENTO A LOS TRABAJADORES PARA RECONOCIMIENTO MÉDICO

Un elemento esencial para poder valorar la situación de incapacidad de un trabajador es la historia clínica. Los inspectores médicos pueden realizar sus valoraciones sin necesidad de citar al trabajador en aquellos supuestos en los que estimen que la información contenida en el historial clínico lo hace innecesario.

Los trabajadores que se encuentren en situación de I.T. podrán ser requeridos a reconocimiento médico y demás actos de comprobación de la I.T., bien por la Entidad Gestora (INSS) o Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social correspondiente.

Igualmente la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades, de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, podrá en todo momento comprobar la situación de I.T. del trabajador y aceptar o no la baja laboral.

La negativa infundada a someterse a los reconocimientos médicos, dará lugar a la extensión del alta laboral por Inspección e igualmente a la pérdida de la prestación económica.

Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo respetando, en todo caso, el derecho a la intimidad y a la dignidad de los trabajadores.

La citación a reconocimiento médico habrá de comunicarse al trabajador con una antelación mínima de cuatro días hábiles.

En dicha citación se le informará de que en caso de no acudir al reconocimiento, se procederá a suspender cautelarmente la prestación económica, y que si la falta de personación no queda justificada en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha fijada para el reconocimiento, se procederá a la extinción del derecho al subsidio.

Si el trabajador justificara, antes de la fecha fijada para el reconocimiento médico o en ese mismo día, las razones que le impiden comparecer al mismo, la Entidad Gestora o Mutua, podrá fijar una fecha posterior para su realización, comunicándolo al interesado con la antelación mínima ya indicada.

Cuando el trabajador que hubiera sido citado a reconocimiento por la Entidad Gestora no se personara en la fecha fijada, el Director Provincial correspondiente dictará resolución, que será inmediatamente comunicada al interesado, disponiendo la suspensión cautelar del subsidio desde el día siguiente al fijado para el reconocimiento, e indicándole que dispone de un plazo de diez días hábiles, a partir de la fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificar la misma.

Cuando el trabajador que hubiera sido citado a reconocimiento médico por una Mutua, no acuda al mismo en la fecha fijada, aquella acordará la suspensión cautelar del subsidio desde el día siguiente al fijado para el reconocimiento, lo que comunicará inmediatamente al interesado indicándole que dispone de un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificarla.

La Entidad Gestora o la Mutua comunicará la suspensión acordada por vía telemática a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Si el trabajador justifica su incomparecencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que estaba citado a reconocimiento médico, el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina dictará nueva resolución, o la Mutua nuevo acuerdo, dejando sin efecto

la suspensión cautelar, y procederá a rehabilitar el pago de la prestación con efectos desde la fecha en que quedó suspendida. En estos casos la Entidad Gestora o Mutua, en el plazo de quince días siguientes a la fecha en que se dicte la resolución o acuerdo, pagará directamente al trabajador el subsidio correspondiente al período de suspensión.

Asimismo, comunicará a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social la resolución o acuerdo por la que la suspensión queda sin efecto, informando de la fecha a partir de la cual procede reponer el pago delegado por parte de la empresa.

Se entenderá que la incomparecencia fue justificada cuando el trabajador aporte informe emitido por el médico del Servicio Público de Salud que le dispense la asistencia sanitaria, en el que se señale que la personación era desaconsejable conforme a la situación clínica del paciente; cuando la cita se hubiera realizado con un plazo previo inferior a cuatro días hábiles, o bien cuando el beneficiario acredite la imposibilidad de su asistencia por otra causa suficiente.

Transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que estaba citado a reconocimiento médico por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, sin que el trabajador hubiera aportado justificación suficiente de su incomparecencia, el Director Provincial correspondiente dictará resolución declarando la extinción del derecho a la prestación económica con efectos desde el día en que hubiera sido efectiva la suspensión. Dicha resolución se notificará al interesado. La Entidad Gestora comunicará la extinción acordada, por vía telemática, al servicio público de salud, a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El inspector médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina podrá expedir el alta médica por incomparecencia en el ejercicio de las competencias previstas en la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que estaba citado a reconocimiento médico por la Mutua correspondiente, sin que el trabajador hubiera aportado justificación suficiente de su incomparecencia, la Mutua acordará la extinción del derecho a la prestación económica con efectos desde el día en que hubiera sido efectiva la suspensión. Dicho acuerdo se notificará al interesado. La Mutua comunicará la extinción acordada, por vía telemática, al Servicio Público de Salud, a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

9. EXPEDICIÓN DE PARTES DE BAJA POR ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T.)

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, el parte médico de baja será extendido por el médico de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social;

excepto en aquellos trabajadores que tengan cubierta las contingencias profesionales con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en los que será extendido por su **médico de familia**.

Para la expedición del **parte de baja por A.T.** será preciso que el **trabajador presente el parte de declaración de accidente expedido por la empresa**.

10. REVISIÓN DE ALTAS MÉDICAS DE A.T. EXPEDIDAS POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

En el artículo 4 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre y su modificación en la Disposición final tercera del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, se señala el procedimiento administrativo de revisión de las altas médicas expedidas en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales. Se indica la posibilidad de instar la revisión del alta médica emitida por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y por las empresas colaboradoras, en el plazo de diez días hábiles siguientes al de su notificación, ante la Entidad Gestora competente (INSS).

A su vez, el médico del Servicio Público de Salud deberá informar al interesado sobre esta posibilidad; y **no extender una baja médica derivada de contingencias comunes** cuando el asegurado no esté de acuerdo con el alta derivado de contingencias profesionales, emitida por la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social; además, con carácter inmediato comunicará a la Entidad Gestora competente la existencia de dos procesos distintos de incapacidad temporal que pudieran estar relacionados.

El interesado que inicie el procedimiento de revisión, lo comunicará a la empresa en el mismo día en que presente su solicitud o en el siguiente día hábil.

El INSS o el Instituto Social de la Marina, en su caso, comunicará a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social competente el inicio del procedimiento especial de revisión para que, en el plazo improrrogable de cuatro días hábiles, aporte los antecedentes relacionados con el proceso de incapacidad temporal de que se trate e informe sobre las causas que motivaron la emisión del alta médica. En el caso de que no se presentara la citada documentación, se dictará la resolución que proceda, teniendo en cuenta la información facilitada por el interesado.

La Mutua Colaboradora con la Seguridad Social correspondiente podrá pronunciarse reconociendo la improcedencia del alta emitida, lo que motivará, sin más trámite, el archivo inmediato del procedimiento iniciado por el interesado ante la Entidad Gestora.

11. EXPEDICIÓN DE PARTES DE BAJA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL

En cumplimiento del Art. 5 del R.D. 1299/2006, ante la sospecha razonable de una enfermedad en cuanto a su posible origen laboral, en razón de los factores de riesgo a que pueda estar expuesto el personal afectado en su lugar de trabajo; el facultativo de atención primaria deberá rellenar el modelo correspondiente de declaración de sospecha de enfermedad profesional, cumplimentado todos sus apartados y remitiéndolo al órgano competente, que en Andalucía es el Servicio de Salud Pública de las Delegaciones Territoriales de Salud.

- Cuando la cobertura de las contingencias profesionales sea por el INSS y el trabajador precise la baja, ésta será extendida por su médico de cabecera marcando la contingencia de enfermedad profesional.
- Si la cobertura fuese a cargo de una Mutua, será derivado a ésta con informe clínico de la enfermedad profesional.
- Periodo de observación de Enfermedad Profesional (E.P.): 6 meses prorrogables otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

12. CAMBIOS DE CONTINGENCIA

El procedimiento para la determinación de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal se podrá iniciar, a partir de la fecha de emisión del parte de baja médica:

a) de oficio, por propia iniciativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Servicio Público de Salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social de la Marina.

b) a instancia del trabajador o su representante legal.

c) a instancia de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesaria para poder determinar la contingencia, incluidos, en su caso, los informes y pruebas médicas realizados.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará la iniciación del procedimiento al Servicio Público de Salud competente, a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o a la empresa colaboradora, según corresponda, cuando el procedimiento no se hubiera iniciado a su instancia y en aquellos asuntos que les afecten, para que, en el plazo improrrogable de cuatro días hábiles, aporten los antecedentes relacionados con el caso de que dispongan e informen sobre la contingencia de la que consideran que deriva el proceso patológico y los motivos del mismo. También se dará traslado al trabajador de la iniciación del procedimiento, cuando esta no hubiera sido a instancia suya,

comunicándole que dispone de un plazo de diez días hábiles para aportar la documentación y hacer las alegaciones que estime oportunas.

El equipo de valoración de incapacidades emitirá un informe preceptivo, que elevará al Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que se pronunciará sobre la contingencia que ha originado el proceso de dicha incapacidad.

Emitido el informe del equipo de valoración de incapacidades el Director Provincial competente del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictará la resolución que corresponda, en el plazo máximo de quince días hábiles. La resolución deberá pronunciarse sobre la determinación de la contingencia, común o profesional y si el proceso es o no recaída de otro anterior, efectos que correspondan y sujeto responsable de las prestaciones económicas y sanitarias.

La resolución será comunicada al interesado, a la empresa, a la Mutua y al servicio público de salud.

13. NUEVA BAJA TRAS ALTA POR INSPECCIÓN MÉDICA DEL SPS

A partir de la fecha de alta por inspección no deberá extender más partes de confirmación, estando sujeto el trabajador, durante el periodo de seis meses, a la situación especial que viene establecida en la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974, por la que se regulan determinadas funciones de la Inspección de Servicios Sanitarios en materia de altas médicas; y que establece que durante dicha situación, las futuras bajas médicas que se originen, deberán tener la autorización de la UMVI. Para ello, se deberá enviar a esa Unidad informe con datos objetivos y detalle del estado clínico del trabajador que justifique la necesidad de la misma. Caso de no ser justificada, la nueva baja podrá ser anulada por la UMVI.

14. NUEVA BAJA TRAS ALTA POR INSPECCIÓN DEL INSS

Según la ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, tras un alta médica por INSS antes de los 365 días en los procesos de IT, el INSS será el único competente para emitir una nueva baja por misma o similar patología, si esta se produce en un plazo inferior a 180 días desde la mencionada alta. Por lo que el trabajador deberá ser remitido por el médico de cabecera a dicho organismo.

Sólo si la nueva baja es por distinta patología, se procederá a la expedición de nueva baja por el médico de cabecera, si éste lo estima necesario.

15. PRESCRIPCIÓN DE NUEVA BAJA TRAS ALTA POR EL FACULTATIVO DEL INSS AGOTADO EL PLAZO DE 12 MESES DESDE EL INICIO DE LA I.T.

Tras los 12 meses de duración de la IT, el facultativo de A. P. no podrá extender alta laboral ni partes de confirmación, cerrando el proceso en Diraya por pase al INSS.

Agotado el plazo de 12 meses de duración y tras alta o denegación de la Invalidez Permanente, por el órgano colegiado EVI del INSS; el trabajador que solicite nueva baja por la misma o similar patología, deberá hacerlo al INSS, ya que su médico de cabecera no es competente para ello hasta que transcurran 6 meses desde el alta o denegación de invalidez.

En caso de producirse nuevo episodio, claramente diferenciado del anterior, podrá dar la baja el médico de A.P.

El médico deberá abstenerse de modificar o cambiar artificialmente el diagnóstico y deberá ajustarse a la realidad clínica del paciente.

16. PROPUESTAS DE ALTA DE LOS FACULTATIVOS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

En los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a una Mutua, cuando ésta, a la vista de los partes médicos de baja o de confirmación de la baja, de los informes complementarios o de las actuaciones de control y seguimiento que desarrolle, considere que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo, podrá formular, a través de los médicos adscritos a ella, propuestas motivadas de alta médica, a las que acompañará los informes y pruebas que, en su caso, se hubiesen realizado. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado, para su conocimiento, que se ha enviado la propuesta de alta.

Las propuestas de alta de las Mutuas se dirigirán a las unidades de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, quienes las remitirán inmediatamente a los facultativos o servicios médicos a quienes corresponda la emisión de los partes médicos del proceso. Estos facultativos deberán pronunciarse bien confirmando la baja médica, bien admitiendo la propuesta, a través de la expedición del correspondiente parte de alta médica.

En el caso de que se confirme la baja, se consignará el diagnóstico, el tratamiento médico dispensado, las causas que justifican la discrepancia y se señalarán las atenciones y los controles médicos que se considere necesario realizar. La Inspección Médica trasladará a la Mutua este informe junto con la actuación realizada en el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la propuesta de alta.

La Inspección Médica del Servicio Público de Salud podrá acordar el alta médica, efectiva e inmediata. En todo caso, la Inspección comunicará a la Mutua, dentro del plazo de los cinco días siguientes a la fecha de recepción de la propuesta de alta, la actuación realizada junto con los informes que el facultativo hubiera remitido.

Cuando la propuesta de alta formulada por una Mutua no fuese resuelta y notificada en el plazo de cinco días establecido en el apartado anterior, la Mutua podrá solicitar el alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las competencias previstas en la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social. La Entidad Gestora resolverá en el plazo de cuatro días siguientes a su recepción.

El INSS realizará el seguimiento del grado de motivación clínica de las propuestas de alta de las mutuas y de respuesta de la inspección médica de los servicios públicos de salud o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, así como el grado de cumplimiento de los plazos de las distintas entidades en lo que se refiere a las propuestas de alta.

17. ORDEN O INDICACIÓN DE ALTA POR LA UMVI

La Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974, establece en su Art. 1: “La Inspección de Servicios Sanitarios, de oficio o en virtud de la información recibida de las Empresas o de los Servicios Médicos de las mismas, podrá decretar, previas las actuaciones que estime procedentes, el alta médica de los trabajadores que se encontraran en situación de I.T. por enfermedad común o accidente no laboral”.

A la vista de ello, cuando el facultativo de A. P. reciba una ORDEN O INDICACIÓN de alta (**No es una propuesta de alta**) deberá proceder a la expedición de la misma por mejoría o curación; y en caso de desacuerdo manifiesto por criterios clínicos, deberá inexcusablemente remitir informe médico justificativo de la decisión tomada a la UMVI con la mayor premura.

18. INCOMPARECENCIA DEL TRABAJADOR A RECOGER LOS PARTES DE CONFIRMACIÓN

Los partes de confirmación se expedirán inmediatamente tras el reconocimiento del trabajador; por lo que en caso de que el mismo no acuda a la fecha prevista por el facultativo para su entrega, éste deberá proceder de forma inmediata a la extensión del alta laboral por incomparecencia.

19. TIPOS DE ALTA POR EL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA

El médico de A.P. podrá extender en Diraya:

- Alta por mejoría o curación
- Alta por incomparecencia
- Alta por fallecimiento
- Alta por traslado
- Alta por inicio nacimiento y cuidado de menor, que se puede dar tanto a la madre o al padre
- Alta Inspección INSS (solo en el caso de que dicha alta haya sido expedida por los médicos del INSS)
- Alta incomparecencia INSS (solo en el caso de que dicha alta haya sido expedida por los médicos del INSS)

20. RECLAMACIONES CONTRA EL ALTA

Ante la disconformidad de un trabajador a un alta laboral, el facultativo de A.P le informará que podrá actuar de la siguiente forma:

1. Reclamaciones contra altas expedidas por el facultativo de A.P: en este caso debe indicar al trabajador que presente una reclamación previa ante la Delegación Territorial de Salud, donde indique los motivos de la misma y aporte los informes médicos de que disponga.
2. Reclamaciones contra altas expedidas por Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: Véase el pto. 9 de este Manual REVISIÓN DE ALTAS MÉDICAS DE AT EXPEDIDAS POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
3. Reclamaciones contra altas por Inspección INSS (altas por los facultativos del INSS): se deberá indicar al trabajador que la reclamación deberá presentarla en el INSS como órgano competente para su resolución.
4. Recurso contra el alta por parte del INSS tras agotar 12 meses de I.T.

El trabajador que no esté conforme con la resolución de alta del INSS tras 12 meses de I.T., podrá recurrir ante la Inspección Médica del Sistema Sanitario Público en el plazo de 4 días naturales desde el día siguiente a la recepción de la resolución (artículo 3, regla primera, R.D. 1430/2009), para lo cual deberá presentar el correspondiente recurso, donde se reflejarán los motivos de este desacuerdo, aportando la documentación clínica que justifique su disconformidad. La Inspección Médica contestará en 7 días naturales dando cuenta al INSS de la conformidad o discrepancia ante el alta emitida, de forma que el INSS revise la situación del trabajador y proceda a la emisión de nueva resolución, donde ratifique o rectifique el alta anteriormente emitida. El silencio administrativo debe entenderse como conformidad con el alta emitida. En caso de denegación de solicitud de nueva baja por igual o similar diagnóstico tras el plazo de 12 meses y haber sido alta por el facultativo del INSS o tras denegación de Invalidez Permanente, deberá presentar el correspondiente recurso ante el INSS, y no ante la Inspección Médica del Sistema Sanitario Público.

5. Las reclamaciones contra las resoluciones del INSS en materia de I.T tras prórroga o de cualquier tipo de invalidez se dirigirán a dicho organismo.

21. INFORMES EN PARTES DE CONFIRMACIÓN

En los procesos de incapacidad temporal cuya gestión corresponda al Servicio Público de Salud y su duración prevista sea superior a 30 días naturales, el segundo parte de confirmación de la baja irá acompañado de un **informe médico complementario** expedido por el facultativo que haya extendido el parte anterior, en el que se recogerán las dolencias padecidas por el trabajador, el tratamiento médico prescrito, las pruebas médicas en su caso realizadas, la evolución de las dolencias y su incidencia sobre la capacidad funcional del interesado. En los procesos inicialmente previstos con una duración inferior y que sobrepasen el periodo estimado, dicho informe médico complementario deberá acompañar al parte de confirmación de la baja que pueda emitirse, en su caso, una vez superados los 30 días naturales.

Los informes médicos complementarios se actualizarán, necesariamente, cada dos partes de confirmación de baja posteriores.

En los procesos cuya gestión corresponda al servicio público de salud, trimestralmente, a contar desde la fecha de inicio de la baja médica, la Inspección Médica del Servicio Público de Salud o el Médico de Atención Primaria, bajo la supervisión de su Inspección Médica, expedirá un **informe de control** de la incapacidad en el que deberá pronunciarse expresamente sobre todos los extremos que justifiquen, desde el punto de vista médico, la necesidad de mantener el proceso de incapacidad temporal del trabajador.

22. INICIO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE

Cuando el facultativo de A.P. considere que un trabajador en I.T no es susceptible de recuperación y por tanto se prevea la imposibilidad de ser recuperado laboralmente, deberá comunicarlo a la UMVI, que procederá a la citación y emisión del correspondiente alta por propuesta de incapacidad permanente para su posterior valoración por el INSS.

23. DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN I.T.

Cuando un trabajador en situación de I.T. comunique a su médico de cabecera desplazamiento temporal a otra provincia distinta a la de su residencia pero dentro de la comunidad autónoma andaluza, el facultativo de A.P. solicitará a la UMVI, desde Diraya, y a través del buzón del profesional del programa informático Sigilum Milenium, la autorización de desplazamiento.

Si el trabajador se desplazara a otra comunidad autónoma, el médico de cabecera deberá cerrar el proceso de IT como alta por traslado.

24. ACÚMULOS DE PERIODOS DE I.T.

El facultativo que emite la baja deberá marcar si es o no **recaída** de un proceso anterior; entendiéndose por recaída, el proceso de I.T. por misma patología que se produce dentro de los 6 meses siguientes al alta de una baja anterior.

A efectos del periodo máximo de duración de I.T. y su posible prórroga se computarán los periodos de recaída y observación.

25. SOLICITUD DE CONTROL DE ASEGURADO

Cuando el facultativo de A.P. tenga que derivar por algún motivo un trabajador a la UMVI, deberá hacerlo a través del buzón del profesional del programa informático Sigilum Milenium, argumentando la causa de la solicitud de control del asegurado.

26. RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LACTANCIA NATURAL

No es una situación de incapacidad temporal (I.T).

Es una prestación independiente para proteger a la mujer trabajadora.

Las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente que por las condiciones específicas de su trabajo puedan estar expuestas a situaciones de riesgo para su salud o la del feto, tendrán derecho a que, el empresario adopte las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación se mantuviera la situación de riesgo, y así lo certifiquen los **Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social**, con el **INFORME del Médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS)** que asista facultativamente a la trabajadora, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. En el supuesto de que no existiese puesto o función compatible, incluyendo la posible movilidad funcional, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de trabajo.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la **situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo**, durante el tiempo necesario para la protección de su salud. En este caso, el Médico de A.P. cumplimentará un **informe indicando semana de gestación (fecha probable de parto) y ausencia de patología**.

Lo anteriormente expuesto será igualmente de aplicación durante el periodo de lactancia natural, si las condiciones del trabajo pueden influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo, hasta que éste haya cumplido nueve meses como máximo.

Prestación económica

La prestación económica cuyo pago corresponderá a la **Entidad Gestora o Colaboradora**, nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día anterior a aquél en que se inicie la suspensión del trabajo por maternidad, o la reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior, o a otro compatible con su estado.

La prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente.

El procedimiento se iniciará a instancia de la trabajadora mediante solicitud dirigida a la Dirección Provincial de la Entidad Gestora o a la Entidad Colaboradora.

La prestación económica será gestionada directamente por la Entidad Gestora (Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Mutua de que se trate).

¿Qué normativa la regula?

- **Ley 39/1999** de 5 de noviembre de **conciliación de la vida familiar y laboral** de las **personas trabajadoras**:
 - Artículo **10**: que modifica el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 - Artículo **14**: que modifica el capítulo IV ter de la Ley General de la Seguridad Social. **Artículos 134-135 LGSS. (art 186-189 RD8/2015 TRLGSS)**
- **RD 1251/2001** de 16 de noviembre que regula las prestaciones de Maternidad y Riesgo durante el embarazo.
- **Ley Orgánica 3/2007**, de 22 de marzo, para la **igualdad** efectiva de mujeres y hombres.

27.PROCESOS DE I.T EN PACIENTES ASEGURADOS EN OTROS PAISES DE LA U.E.

ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL

ESTANCIA TEMPORAL EN ESPAÑA

En caso de que el trabajador esté desplazado temporalmente en España (incluida circunstancia de vacaciones), y presente una enfermedad que le incapacite temporalmente para su trabajo, el médico que se le asigne y siempre bajo su criterio profesional, emitirá los documentos oficiales de partes de baja, alta y confirmación como a cualquier trabajador español y con la misma periodicidad.

Además deberá formalizar el **formulario E-116** *"Informe médico en caso de incapacidad para el trabajo"*. Este formulario se cumplimentará la primera vez y cuando el INSS lo solicite como complementario. Se trata de un formulario de enlace entre las administraciones de seguridad social de los países implicados.

El asegurado, en el plazo de **tres días**, tiene la obligación de presentar en el **INSS** los ejemplares del parte de baja junto con el formulario E-116 y tarjeta sanitaria europea o del certificado provisional sustitutorio de la misma para su remisión al organismo del país de origen, al objeto de que se proceda por parte de este último, al pago al interesado del subsidio a que tuviera derecho.

Los **gastos médicos** ocasionados por la asistencia a estos trabajadores se facturarán al país de origen del trabajador. Para ello será necesario formalizar el **modelo de asistencia H-1** *(incluidos los de asistencia en cada una de las consultas médicas necesarias para expedir los partes de baja, confirmación y alta)* en el centro de salud *firmado por el médico* que lo asista, para su remisión al Distrito para que éste proceda a la facturación correspondiente.

DESTACADOS EN ESPAÑA POR SU EMPRESA

Igual procedimiento que en el caso anterior.

ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL OCURRIDOS EN ESPAÑA

A los ciudadanos de otros Estados miembros destacados laboralmente en España con cobertura de asistencia sanitaria en base a la tarjeta sanitaria europea o certificado provisional sustitutorio emitido en su país de origen, y que precisen una incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o de

enfermedad profesional, le serán expedidos los correspondientes partes de baja, confirmación y alta como a cualquier trabajador español.

Por cada una de las consultas médicas que requiera el trabajador miembro de la U.E, se expedirá el correspondiente modelo H-1, el cual será enviado al centro de facturación establecido por cada distrito sanitario.

DESCANSO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR EN ESPAÑA

Cuando una trabajadora de un país miembro de la U.E. precise la prestación de descanso por nacimiento y cuidado de menor, le será de aplicación la misma normativa que para una trabajadora española.

Se deberá cumplimentar el modelo oficial de descanso por maternidad recogido en la Circular de la Consejería de Salud y S.A.S. sobre control de la incapacidad laboral una sola vez, unido al formulario **E-116** y la cumplimentación del modelo H-1 en cada una de las visitas médicas que precise, para su posterior FACTURACIÓN.

28.PROCESOS DE I.T EN PACIENTES ASEGURADOS EN OTROS PAÍSES MIEMBROS DE LA U.E. QUE SE TRASLADAN A ESPAÑA

Los ciudadanos de otros Estados miembros, o ciudadanos españoles que trabajen en ellos que hayan iniciado en un proceso de incapacidad temporal o maternidad, pueden ser autorizados por el organismo competente de dicho país a trasladarse a España.

Los requisitos necesarios y el procedimiento a seguir será el siguiente:

PROCESOS DERIVADOS DE ENFERMEDAD COMUN O ACCIDENTE NO LABORAL

Deberán venir provistos del formulario **E-112** "Certificación sobre *mantenimiento de las prestaciones en curso de enfermedad- maternidad*".

El médico de A.P asignado en España, en base al formulario E-112 que el trabajador le presente, le atenderá y expedirá los modelos de baja, confirmación y alta como si de un trabajador español se tratara. Así mismo y al igual que en cualquier otra asistencia médica, se cumplimentará el modelo H-1 para facturación al país de origen. El trabajador presentará toda la documentación en la Dirección Provincial del INSS.

NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR

Igual procedimiento al anterior, salvo que al tratarse de un descanso y no de una I.T el modelo a cumplimentar es el mismo que a cualquier embarazada española con la indicación de fecha del parto o fecha probable de parto.

PROCESOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Deberán venir provistos del formulario **E-123** "Certificación de *derecho* a las prestaciones en especie del seguro contra los *accidentes de trabajo y enfermedades profesionales*".

El médico de A.P. asignado en España, en base al formulario E-.123 que el trabajador le presente, le atenderá y expedirá los modelos de baja, confirmación y alta como si de un trabajador español se tratara.

El formulario E-123 marca el periodo de baja autorizado. Una vez finalizado este periodo, el asegurado puede solicitar una prórroga al Organismo extranjero asegurador a través del INSS.

El parte de alta deberá emitirse al finalizar el periodo autorizado, siempre que coincida con el criterio facultativo. De no coincidir, el trabajador podrá solicitar una prórroga.

Si el Organismo asegurador no concede la prórroga, dejará de recibir el subsidio aunque su médico en España continúe emitiendo partes de confirmación.

Así mismo y al igual que en cualquier otra asistencia médica, se cumplimentará en modelo H-1 para facturación al país de origen.

El trabajador presentará toda la documentación en la Dirección Provincial del INSS.

Nota: Hasta que finalice el periodo transitorio para la transmisión de datos entre instituciones, establecido en la Decisión E-4 publicada en el DOUE de 20 de mayo de 2014, el procedimiento regulado en el art 27 del Reglamento CE 987/09 podrá coexistir con la utilización de los formularios E-115, E-116, E-117, E-118.

29. TRASLADO DE DOMICILIO A OTRO PAIS EN SITUACIÓN DE I.T.

Trabajador con menos de 365 días en IT

El traslado de un trabajador a un país incluido en los Reglamentos Comunitarios o con el que está suscrito un convenio bilateral se autorizará por el Servicio Público de Salud mediante el correspondiente formulario y su periodo de validez. Si no se determina el plazo de validez, se entenderá autorizado por un plazo máximo de 3 meses.

El control de la IT se efectuará por la institución competente del país del nuevo domicilio, a quien se solicitará el informe médico cada 3 meses. A su vez se solicitará al interesado un informe médico mensual emitido por su médico

habitual. Si el trabajador no justifica el mantenimiento de su situación en IT al no enviar los informes médicos requeridos, el subsidio podrá ser suspendido.

Trabajador con más de 365 días en IT

Será la Dirección Provincial del INSS correspondiente la que autorice el traslado de dicho trabajador, dado que es el INSS el único competente para valorar el proceso de IT con más de 365 días de duración.

Trabajador que desea trasladarse a un país con el que no existe Convenio bilateral

En el supuesto de inexistencia de Convenio Internacional o cuando en el convenio de aplicación no esté prevista la figura del “enfermo autorizado”, a un trabajador que inicia un proceso de IT en España, y durante el tratamiento traslada su domicilio a otro país, se le podrá anular el subsidio de IT al no ser exportable la prestación.

30.I.T. Y NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR

En caso de que la embarazada estuviese en situación de IT hasta 365 días (a partir de 365 días, es el INSS quien suspende automáticamente la prestación y, en caso de recaída, los interesados deben solicitar ante dicho Organismo, una vez finalizada la prestación, solicitud de recaída), el Médico de Familia deberá extender un parte de alta médica (P9), día anterior al parto, por inicio de la situación de maternidad (independientemente de si la baja tiene o no relación con el embarazo), y **con la siguiente causa (nº 20): “INICIO DE MATERNIDAD” (desde R.D. Ley 6/2019, se denomina “Fin de IT por inicio de Nacimiento y Cuidado de Menor comunicado por SPS”, comenzando el disfrute del descanso por nacimiento y cuidado menor, desde el mismo día del parto.** Este documento deberá ser remitido a la Entidad Gestora el mismo día o el día hábil posterior.

Si transcurrido el descanso, la anterior situación de incapacidad temporal persistiera, se reanudará el cómputo interrumpido. En este caso el Médico de Familia del Servicio Público de Salud emitirá un parte médico de baja con el mismo código diagnóstico de la baja inicial, en el que se cumplimente el **indicativo de RECAÍDA.**

Durante el descanso por nacimiento y cuidado de menor no procederá emitir partes de baja.

Desde R.D. Ley 6/2019, misma actuación **si el padre** está en situación de IT.

Las instrucciones recibidas indican:

“Se amplía la causa de alta 20, pasa a denominarse” Fin de IT por inicio de Nacimiento y Cuidado de Menor comunicado por SPS” (se utilizará, como estaba siendo hasta ahora, para los supuestos de inicio de

maternidad y también para el inicio de paternidad). Deja de tener efecto el tipo de error 80, que estaba referido a la maternidad por parto.”

En los supuestos en que a la madre le sea de aplicación el Estatuto de los Trabajadores (ET), ésta puede iniciar el descanso hasta 4 semanas anteriores a la fecha del parto, **por tanto, se debe expedir informe maternal, teniendo en cuenta que desde la fecha inicio descanso al día anterior a la fecha probable de parto, debe ir un máximo de 28 días, y, en caso de un período inferior, tener en cuenta que debe ser en períodos semanales.**

31.I.T. Y PLURIEMPLEO/PLURIACTIVIDAD

Se emitirán los documentos de baja para todas las empresas y regímenes para los que presta servicio (lo mismo cabe decir de los partes de confirmación), es decir, se entregarán tantos partes de baja originales como trabajos tenga el trabajador.

Tanto la baja como el alta deberán ser simultáneas en todas empresas.

Si es una enfermedad protegida como accidente de trabajo (infarto), se considera como accidente laboral. Las denominadas enfermedades del trabajo tienen la consideración de accidente de trabajo.

En los trabajadores encuadrados en más de un régimen de la Seguridad Social (pluriactividad) y que sufran un accidente que tiene lugar como consecuencia de la prestación de servicios o del ejercicio de la actividad profesional en uno u otro régimen, se ha de tener en cuenta que el concepto de accidente de trabajo está legalmente vinculado a la actividad concreta que se desempeñaba o a la que el trabajador se dirigía a desempeñar en el momento de producirse el accidente. Es decir, las lesiones sufridas con ocasión o como consecuencia de la actividad desarrollada en el momento de acaecer el accidente, se considerarán derivadas de accidente de trabajo (AT) sólo en el régimen en el que se estaba desempeñando esta actividad y no en un régimen distinto.

Esta consideración también se extiende a los accidentes in itinere, a los accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores autónomos económicamente dependientes y a las enfermedades que reciben el tratamiento de accidentes de trabajo.

32.I.T Y DESEMPLEO

El trabajador en situación de desempleo contributivo que solicita una baja, está en una situación asimilada a activo; y se puede extender el parte de baja. Percibirá la prestación por IT en cuantía igual a la prestación por desempleo.

Si la IT es una recaída de un proceso anterior (cuando trabajaba) y finalizada la duración del desempleo, continúa en situación de IT; seguirá percibiendo la prestación por IT en la misma cuantía que la venía percibiendo.

El período de percepción de la prestación por desempleo no se ampliará por la circunstancia de que el trabajador pase a situación de IT o maternidad.

Si el trabajador está en situación de desempleo no contributivo, no procede emitir baja médica. Si fuera necesario justificar la situación de enfermedad, el Médico de Familia realizará un informe clínico.

33.I.T. Y VACACIONES O PERMISOS

Los trabajadores en situación de incapacidad temporal tienen derecho a disfrutar de vacaciones en un momento posterior al establecido, tanto si la incapacidad se inició antes de la fecha prevista para sus días de descanso, como si sobrevino precisamente durante estos días.

En situación de excedencia, no cabe emitir parte de baja médica por no ser situación de activo. En caso de asistencia a clases o exámenes, no se rompe la situación legal de IT, sólo podría desaconsejarse por razones clínicas.

34. SOLICITUD DE BAJA POR MOTIVOS SOCIOLABORALES

En numerosas ocasiones, los problemas económicos, laborales, familiares y sociales intervienen junto a la causa principal de solicitud de IT por parte del paciente. Es evidente que la necesidad de tener en cuenta los aspectos éticos de nuestra práctica clínica, junto al manejo coordinado de toda la información del enfermo, es de vital importancia; y, por supuesto, poseer habilidades de comunicación.

La única causa que contempla la normativa para la IT es el estar incapacitado médicamente para el trabajo y precisar asistencia sanitaria.

La baja laboral no es sino un acto médico de certificación que ha de incorporar, además de las variables puramente clínicas, las características y condiciones del puesto de trabajo. El médico de cabecera debe estar concienciado de la responsabilidad que supone gestionar los recursos, siempre limitados, que la sociedad asigna para su distribución.

35. SOLICITUD DE BAJA DE PERSONAS SIN DERECHO A I.T.

Recordar que para ser titular de la prestación es preciso estar en alta o en situación asimilada al alta y además haber cotizado un período mínimo de 180 días en los cinco años anteriores en el caso de la enfermedad común, no exigiéndose este requisito de la cotización en caso de accidente sea o no de trabajo y de enfermedad profesional, por lo que no procede extender el parte de baja por IT a quien no cumpla con los requisitos.

Es importante solicitar siempre el documento de afiliación a la Seguridad Social, además de su DNI.

36.I.T. E INGRESO EN PRISIÓN

En el caso de un paciente de nuestra consulta, que estando en situación de IT es recluido en centro penitenciario, procede mantener la IT; ya que no es causa legal de alta, suspensión o extinción del derecho a la prestación por IT.

El médico gestionará esta situación recabando informes del servicio médico de la prisión, a través del familiar a quien entregue los partes. En caso de imposibilidad para obtener esta información lo comunicará a la UMVI para su conocimiento.

37.I.T. Y LISTAS DE ESPERA

El Médico de Familia debe valorar si, durante la espera, el trabajador sigue estando incapacitado para el trabajo o si, por el contrario, puede incorporarse al mismo, en cuyo caso procede la emisión del parte de alta.

Estar a la espera de una prueba diagnóstica y/o tratamiento médico o quirúrgico; no debe ser considerado como único y suficiente motivo para acceder a una situación de IT.

Si para la realización de una prueba diagnóstica o para la aplicación de un tratamiento se precisa una nueva baja laboral, y siempre que no hayan transcurrido más de seis meses desde la emisión del anterior parte de alta, ésta se emitirá como recaída.

38.NEGATIVA DE UN TRABAJADOR EN I.T. A SEGUIR EL TRATAMIENTO PRESCRITO

El derecho al subsidio por IT podrá ser suspendido cuando, sin causa razonable, el paciente rechace o abandone el tratamiento que le hubiesen prescrito. El Médico de Familia debe comunicarlo a Inspección Médica para que inicie los trámites del alta.

39. TRABAJADOR QUE HA RECIBIDO ASISTENCIA SANITARIA AJENA AL S.A.S.

Legalmente es un requisito imprescindible para extender la baja laboral encontrarse recibiendo asistencia sanitaria por la Seguridad Social, en nuestro caso, por el Servicio Andaluz de Salud o cualquiera de las empresas públicas del

Sistema Sanitario Público de Andalucía, y por tanto la asistencia sanitaria prestada por servicios ajenos no da derecho a situaciones de IT.

En estos casos es conveniente valorar los distintos aspectos: razones para la asistencia en servicios ajenos listas de espera, tipo de patología compleja, necesidad del tratamiento a juicio del médico de familia, etc.

Si se estima adecuada la IT, como Médico de Familia deberemos:

- Asumir el control y seguimiento del proceso.
- Recibir información clínica fidedigna y suficiente.
- Consultar con la Inspección Médica.

40. SOLICITUD DE I.T. CON CARÁCTER RETROACTIVO O ADELANTADO

La baja laboral debe prescribirse tras el oportuno reconocimiento médico que constate la incapacidad para trabajar por razones clínico-funcionales; por tanto, es improcedente la emisión de una IT con efectos retroactivos o adelantados.

Sólo en caso de causa razonable (ingreso hospitalario urgente, por ejemplo) podrá aceptarse la IT con carácter retroactivo, y en cualquier caso, consultada la Inspección Médica.

41. BAJAS LABORALES EN TRABAJADORES QUE TIENEN RECONOCIDO UN GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE

Los trabajadores que tengan previamente reconocido un grado de incapacidad permanente mediante resolución del INSS, y que legalmente no les impida desarrollar un trabajo por cuenta propia o ajena, tienen derecho a la baja laboral por esta nueva actividad.

Cuando el facultativo considere que es necesaria la baja laboral, podrá extender el parte de baja; si bien, deberá tener una especial vigilancia de estos procesos, pues el trabajador ya tiene una invalidez concedida. Estos casos pueden detectarse por la prestación farmacéutica como pensionistas.

42. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

Según la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, se añade un nuevo capítulo IV sexies al Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y denominado “Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave”.

El art 135.quater, reconoce una prestación económica a los progenitores,

adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, en aquellos casos en que ambos trabajen, para el cuidado del menor/es que estén a su cargo y se encuentren afectados por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que requiera ingreso hospitalario de larga duración, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Reglamentariamente se han determinado las enfermedades consideradas graves, mediante un listado que aparece en el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Será requisito indispensable que el beneficiario reduzca su jornada de trabajo, al menos, en un 50 por 100 de su duración, a fin de que se dedique al cuidado directo, continuo y permanente, del menor. La prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100 por 100 de la base reguladora equivalente a la establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.

Esta prestación se extinguirá cuando, previo informe del Servicio Público de Salud, cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente, del hijo o del menor acogido por parte del beneficiario, o cuando el menor cumpla los 18 años. El derecho a percibirla sólo podrá ser reconocido a favor de uno de los progenitores. La gestión y el pago de la prestación económica corresponderán a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, a la Entidad Gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

En el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 49 apartado e), se concederá permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Orden de 13 de octubre de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por incapacidad laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social.

Orden 21 de marzo de 1974, por la que se regulan determinadas funciones del Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social en materia de altas médicas.

Orden de 5 de abril de 1974, por la que se actualiza el baremo de lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, previsto en el artículo 146 de la Ley de la Seguridad Social.

Real Decreto Legislativo 1/1994, 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, Orden de 18 de, enero de 1996 para su aplicación y desarrollo.

Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social.

Real Decreto 576/1997, de 18 de abril, por la que se modifica el Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1991/1995, de 7 de diciembre

Ley 39/1999 de 5 de noviembre que modifica el capítulo IV de la Ley General de la Seguridad Social.

RD 1251/2001 de 16 de noviembre que regula las prestaciones de Maternidad y Riesgo durante el embarazo.

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Médicas Fiscales. Administrativas y del Orden Social, que modifica y añade el apartado I del Artículo 131 bis del Real Decreto Legislativo (/1994, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Real Decreto 1273/2003 de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, por el que se modifica el Reglamento general sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Ley 30/2005 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el 2006 en su disposición adicional cuadragésimo octava, establece la nueva redacción de los art. 128 y 131 bis de la Ley General de la seguridad Social

Real Decreto 1299/2006 de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Ley 40/2007 de 4 de Diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, marzo, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia.

Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal.

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina asumirán competencias en relación con la gestión de la prestación por incapacidad temporal.

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, de actualización del régimen de complementos para la situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se aprueba la Instrucción 2/2016, de 29 de noviembre, por la que se dictan normas sobre tramitación para el reconocimiento del abono del complemento de la prestación económica en la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes y situaciones asimiladas.

Primer Marco Director de la Inspección de los Servicios Sanitarios de Andalucía 2017-2019.

Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave.

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 23 de octubre de 2017, por el que se regula el permiso del personal incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave.

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017-2020.

Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022.

Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz.

Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Resolución de 29 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022.

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

Criterio de gestión: 22/2022, de 16 de diciembre de 2022 de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica, en materia: Accidente de trabajo en pluriactividad.

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.